PROTOCOLLO 26

Scivolamento anteriore del condilo

Migliorare la traslazione condilare necessaria all'apertura completa

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata con ridotta traslazione
- ✓ Deflessione verso il lato rigido
- ✓ Fase successiva alla distrazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Presa

Stessa presa intraorale della distrazione caudale.

2



FASE 2

Distrazione iniziale

Applica una leggera distrazione caudale.

3



FASE 3

Scivolamento

Aggiungi una spinta in direzione anteriore e leggermente mediale.

4



FASE 4

Ritorno

Rilascia lentamente seguendo il percorso inverso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Integrazione	seguita da apertura attiva

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Sempre preceduta da una lieve distrazione
- ✓ Osserva la traiettoria di apertura dopo la tecnica
- ✓ Confronta la traslazione tra i lati

Errori da evitare

- ! Spinta senza distrazione
- ! Direzione eccessivamente laterale
- ! Range forzato oltre la tolleranza

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con protrusione	Aprire guidando il mento leggermente in avanti	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La traslazione condilare è essenziale oltre i primi 20 a 25 mm di apertura.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.